RSI-Checkliste

1 TEAM-TIME-OUT durch Notärzt:in

Aufgaben	**NA Lead, Airway + Checklisten verteilen** **Material A+B** | Welche **Medikamente?** **Lagerung / PVK / Monitor**
Lagerung	**Oberkörper leicht erhöht** | **Gehörgang = Jugulum** | Unterlage?
Zugang	**Sicher / läuft frei?** | 2. PVK? | Sono benötigt?
Monitor	**SpO_2 + Ton an** | **EKG** | **Kapno aktivieren** **NIBP mit 1 min-Intervall**, nicht am PVK-Arm
Präoxy	**Beutel + Demand + PEEP + Kapno** oder **Reservoirmaske** zusätzlich Nasenbrille mit max. Flow? | **Ziel: 100 %** (über 94 %)
Erwäge	**NIV**: Start PEEP 5 / ASB 3 | **DSI**: Start Ketamin 1 mg/kg **SALAD** | **Diff. Airway**: Lig. cricothyr. markieren (Sono)

LAUT VORLESEN – Antwort abwarten – abhaken

2 FINAL CHECK

- ☐ **Wer macht was?** **Assistenz ITN** **Medikamente** **Check / Monitor / Doku**
- ☐ **Lagerung gut?**
- ☐ **Sauerstoff 2 Liter-Flasche: über 100 bar?**
- ☐ **Sättigungs-Ton laut?**
- ☐ **EKG angeschlossen?**
- ☐ **Kapno-Kurve sichtbar?** \| **Stethoskop** bereit?
- ☐ **NIBP nicht am PVK-Arm?** \| **1 min-Intervall gestartet?**
- ☐ **Zugang getestet** \| **Infusion voll offen?**
- ☐ **Welche Medikamente sind bereit?** \| **NA Medikamente vollständig?**
- ☐ **Videolaryngoskop an? Spatel** **Gr. ?** \| **Tubus** **Gr. ?**
- ☐ **Führungsstab angepasst?** \| **Blockerspritze?**
- ☐ **Absaugung getestet?** Noch nicht einschalten
- ☐ **Griffbereit? Plan B:** hyperangulierter (D- bzw. X-) Spatel + ggf. Bougie
  Plan C: LAMA **Gr. ?** \| **Plan D:** Maske \| **CICO Koniotomie**
- ☐ **Ausreichend präoxygeniert?** mindestens 3 min, SpO_2 über 94 %?
- ☐ **Apnoe-Oxygenierung starten?** mit Nasenbrille
- ☐ **RR über 140 mmHg?** Noradrenalin oder Ethedrin vor Einleitung?

- ☐ **Checkliste vollständig. Unklarheiten oder Bedenken?**
- ☐ **Absaugung einschalten**
- ☐ **Weiter mit Einleitung**

Hanno Koller

CC BY NC ND

notfallstruktur.org

CH \| 21.10.26

LAUT VORLESEN – Antwort abwarten – abhaken

3 CHECK NACH INTUBATION

- ☐ **Kapno-Kurve eindeutig?**
- ☐ **Auskultation: Magen frei? Seitengleiches Atemgeräusch?**
- ☐ **Zahnreihe?**
- ☐ **Tubusfixierung?**
- ☐ Cuffdruck?
- ☐ **Aktuelle Sättigung?** SpO_2 ↓ → AMV↑, PEEP? | **Aktueller Blutdruck?** RR ↓ → Noradrenalin Push-Dose / Perfusor?
- ☐ **O_2-Reserve sicher ausreichend für Transport?** 2. Oxybag?
- ☐ **Magensonde legen?** v. a. bei Larynxmaske / I-Gel
- ☐ Bei Hinweisen auf **Pneumothorax: Thorakostomie?**
- ☐ **Timer für Erhaltungsdosis gestellt?**
- ☐ **Notfall- und Erhaltungsmedikamente aufgezogen + ausreichend?**

4 Check vor Transportbeginn im RTW

- ☐ **Erneute Auskultation + Zahnreihe prüfen**
- ☐ **Gänsegurgel + Zugentlastung** mit Klemme
- ☐ **O_2 ausreichend, Flasche offen?** RTW | Beatmung | Oxybag
- ☐ **Einstellungen Beatmungsgerät prüfen**
- ☐ **Patient vorangemeldet?**

! BEATMUNGSNOTFALL

D	Dislokation	**H**	An die Hand, FiO_2 100 %
O	Obstruktion	**A**	Absaugen / Magensonde
P	Patient	**N**	Neueinstellung Gerät
E	Equipment	**D**	Diagnostik: Auskult., Sono, BGA
S	Stomach / Sedation	**S**	Magensonde / Narkosevertiefung

CC BY NC ND

Material-Checkliste

Vorbereiten und abhaken – nicht vorlesen

1 Absaugung

- ☐ **Kurztest**, Fingertipp geschlossen lassen
- ☐ Mit **Yankauer-Katheter** neben Kopf legen + **Info an** NA

2 Beatmung & Sauerstoff

- ☐ **Beatmungsbeutel mit** — in dieser Reihenfolge
- ☐ – **Demand-Ventil** oder Reservoirbeutel, Flow 15 l/min
- ☐ – **PEEP-Ventil**
- ☐ – **Kapno-Sensor** + an Monitor anschliessen + aktivieren
- ☐ – **Filter**, **Gänsegurgel** und **Maske**
- ☐ **O_2 über 100 bar** (gilt nur für 2 Liter-Flasche)
- ☐ **Guedeltubus** + korrekte Grösse abmessen
- ☐ Nach Rücksprache: **Nasenbrille** + max. Flow

3 Intubation

- ☐ **Videolaryngoskop**
- ☐ – **Spatel** Gr. 4 | 3 | hyperangulierter (D- bzw. X-) Spatel | ____
- ☐ – **Akku** über 30 min?
- ☐ **Tubus** Gr. 7 | 8 | ____
- ☐ – **Führungsstab anpassen:** Hockey-Stick = Standard
  – Hyperangulierte Spatel: Tubus nach Spatelkrümmung biegen
  – Kein Gleitgel verwenden (Rücksprache bei Bougie)
- ☐ – **Blockerspritze** 10 ml
- ☐ – **Fixierung** ggf. unter den Hals des Patienten legen
- ☐ – Cuffdruck-Messgerät (falls vorhanden)
- ☐ **Stethoskop** um den Hals hängen

B PLAN B — in Reichweite legen, nicht auspacken

- ☐ **Magill-Zange**
- ☐ **Bougie + Gleitgel**
- ☐ **Larynxmaske** oder **I-Gel** Gr. 3 | 4 | 5 | ____
- ☐ **Koniotomie-Set**

Fragen sofort ansprechen | Info an NA, wenn alles vorbereitet

CC BY NC ND

notfallstruktur.org

Hanno Koller

CH | 21.10.26

Medikamenten-Checkliste

Vorbereiten und abhaken – nicht vorlesen, nicht verabreichen

1 Immer vorbereiten

☒ **Noradrenalin-Push-Dose**-Lösung („Kölbli“): 10 µg/ml
– Aufziehen: 1 mg Noradrenalin in 100 ml NaCl
– **1.** Double-Check | **2.** Kennzeichnen „NOR 10 µg/ml“
– Entnahmekanüle und 5-ml-Spritze kennzeichnen und aufsetzen

2 Rezept wählen

nach Rücksprache mit **NA**

○ **Rezept 1**	○ **Rezept 2**	○ **Rezept 3**	○ **Individuell**
• **Ketamin**	• **Fentanyl**	• **Fentanyl**	⬇
• **Midazolam**	oder Sufentanil	oder Sufentanil	**3** Auswahl ankreuzen
• Rocuronium	• **Propofol 1 %**	• **Midazolam**	
	• Rocuronium	• Rocuronium	

Erhaltung mit: ○ Midazolam ○ Ketamin ○ Propofol (Bolus / Perfusor?)

3 Medikamente aufziehen

Mengen-Vorgabe beachten

☐ **Fentanyl** 500 µg (50 µg/ml)

☐ **Sufentanil** 50 µg (5 µg/ml)

☐ **Ketamin**
200 mg (10 mg/ml oder 50 mg/ml)

☐ **Midazolam**
10 mg (5 mg/ml oder 1 mg/ml)

☐ **Propofol 1 %**
200 mg (10 mg/ml)

☐ **Rocuronium** 100 mg (10 mg/ml)

4 Nach Rücksprache zusätzlich

☐ **Ephedrin:** 1 Amp. 50 mg / 5 ml = 10 mg/ml
☐ **Atropin:** 0,5 oder 1 mg (nach Vorhaltung)
☐ **Adrenalin-Push-Dose**-Lösung: 10 µg/ml (Vorbereitung vgl. NOR)
☐ **Noradrenalin-Perfusor:** Variante 10 µg/ml aus Push-Dose-Lösung
– Optimal: 2. PVK → Rücksprache mit **NA**
– Aufziehen: 50 ml aus NOR-Push-Dose-Lösung („Kölbli“) 10 µg/ml
– 1. Double-Check | 2. Bekleben: Perf.-Spritze + Leitungsende
– Laufrate: **Start mit 30 ml/h = 5 µg/min**
CAVE: Abweichende Dosierungen bei Datenbanknutzung
– Über 3-Wege-Hahn an (2.) PVK anschliessen

Fragen sofort ansprechen | Info an NA, wenn alles vorbereitet

CC BY NC ND

notfallstruktur.org

Hanno Koller

CH | 21.10.26